

IPD Discharge & Claim Process Optimization

รายงานการวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วยประกันสุขภาพ (Cross-Functional Workflow & SOP)

ขอบเขตงาน

IPD - เวชระเบียน - ประกัน

เป้าหมาย SLA

ลดจาก 6.5 เหลือ 2.5 ชม.

อัตราการลดเวลา

-61.5% (-240 นาที)

กลยุทธ์หลัก

Parallel & Auto-Alert

390 นาที

เวลาเดิม (As-Is Lead Time)

150 นาที

เป้าหมายใหม่ (To-Be SLA)

90%+

เป้า First-Time Pass Rate

1. การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis - RCA)

1. Physical Transport & Waiting Time

การรอเจ้าหน้าที่เวชระเบียนเดินมารับแฟ้มกระดาษตามรอบ (11:30 น.) ทำให้เกิด Bottleneck สูงถึง 90 นาที ซึ่งเป็นขั้นตอนไร้มูลค่า (Non-Value Added Waste) ที่เกิดจากการพึ่งพาแฟ้มเอกสารกายภาพ

2. Data Redundancy & Manual Entry

พยาบาลต้องคัดลอกข้อมูลจาก Discharge Summary กระดาษลงระบบ HIS ซ้ำซ้อน ทำให้เสียเวลา เพิ่มความเสี่ยงข้อมูลคลาดเคลื่อน และความล่าช้าในการเริ่มกระบวนการถัดไป

3. Sequential Line Operations

การทำงานแบบส่งต่อเป็นทอดๆ (แพทย์ → พยาบาล → เวชระเบียน → ประกัน) ขาดการประมวลผลแบบขนาน (Parallel Processing) ทั้งที่ระบบ HIS สามารถแจ้งเตือนข้ามแผนกได้

4. Lack of Pre-submission Audit

ส่งเอกสาร Fax Claim โดยไม่มีการเช็คประวัติเก่า/ความสมบูรณ์ก่อน นำไปสู่การเกิด Query จากบริษัทประกัน ต้องเสียเวลาโทรตามค้นเอกสารเพิ่มเติม ยืดเวลาออกไปอีก 1-2 ชั่วโมง

2. หลักการปรับปรุงกระบวนการใหม่ (To-Be Design Principles)

กลยุทธ์การรันกระบวนการแบบขนานและการตรวจสอบเชิงรุก (Parallel & Proactive Framework)

- Parallel Trigger:** เมื่อแพทย์บันทึก Discharge คำสั่งจะยิง Auto-Alert ไปยัง Coder และเจ้าหน้าที่ประกันทันที โดยไม่ต้องรอแฟ้มกระดาษ
- Pre-Discharge Checklist:** พยาบาลตรวจรับรองความครบถ้วนของเอกสารประวัติการรักษาผ่าน Checklist ในระบบก่อนส่ง เพื่อลดการ Query ย้อนกลับ 100%
- E-Document Usage:** ใช้การสแกน/ดิจิทัลไฟล์ Digital Record จาก HIS/EMR สำหรับงาน Coding และ Fax Claim โดยตรง

3. ตารางเปรียบเทียบ As-Is vs To-Be Workflow

ขั้นตอน (Step)	กระบวนการเดิม (As-Is)	กระบวนการใหม่ (To-Be)	As-Is	To-Be (SLA)
1. สั่ง Discharge	แพทย์เขียนใส่แฟ้ม พยาบาลคัดย้ ลออกลง HIS	แพทย์สั่งใน HIS + เลือก Form สรุปเบื้องต้น ระบบยิง Auto-Alert ข้ามแผนก	30 นาที	15 นาที
2. ตรวจสอบเอกสาร	พยาบาลรวบรวมแฟ้ม โทรแจ้ง รอ เดินหียบแฟ้มกระดาษ	พยาบาลทำ Pre-Claim Checklist ในระบบ เพื่อยืนยันประวัติ/ผล Lab ครบถ้วน	90 นาที	15 นาที
3. สรุปรหัสโรค	เวชระเบียนรอรับแฟ้มกระดาษ แล้วเปิดเล่มสรุป ICD-10	Coder ตรวจสอบ EMR ทันทีหลัง รับ Alert และบันทึก Final ICD-10 ในระบบ	45 นาที	20 นาที
4. ยื่นเคลมประกัน	เจ้าหน้าที่ประกันรับแฟ้ม สแกน เอกสารส่ง Fax Claim	ดึง E-Document ที่ผ่าน Audit ยื่น E-Claim / Fax Portal ทันทีหลัง Coding เสร็จ	90 นาที	30 นาที
5. พิจารณาเคลม	ประกัน Query ประวัติเพิ่ม ต้อง ตามค้นเอกสารเก่าส่งซ้ำ	บริษัทประกันพิจารณาเอกสารที่ สมบูรณ์ (ลดการ Query ลง >90%)	110 นาที	50 นาที
6. ชำระเงิน/กลับ บ้าน	แจ้งยอดส่วนต่าง ชำระเงิน พิมพ์ ใบเสร็จ ให้ยากลับบ้าน	การเงินออกใบเสร็จ พยาบาล แนะนำการดูแลและมอบยากลับ บ้าน	25 นาที	20 นาที
ระยะเวลาทั้งหมด (Total Lead Time)			390 นาที	150 นาที

4. โครงสร้าง SOP และ Action Plan (Excel-Friendly Structure)

No.	ผู้รับผิดชอบ (Role)	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Action Steps)	SLA	ระบบ/เครื่องมือ	KPI / Control Point
1	แพทย์ผู้ดูแล	บันทึก Discharge Summary & Diagnoses เบื้อง ต้นใน EMR พร้อมยืนยันคำสั่ง Discharge	15 นาที	HIS / EMR Module	% Summary ครบถ้วนทันที ≥ 95%
2	พยาบาล IPD	ตรวจเช็ค Pre-Discharge Checklist (ผล Lab, EKG, X-Ray, ประวัติเก่า) แล้วกด "Ready for Claim"	15 นาที	IPD Nursing / Auto-Alert	Zero Missing Doc ก่อนส่งต่อ
3	เวชระเบียน (Coder)	รับ Notification ตรวจสอบ EMR ยืนยันรหัส ICD-10/ICD-9-CM ลงในระบบ HIS	20 นาที	HIS Medical Record	Coding Accuracy ≥ 98%
4	เจ้าหน้าที่ประกัน	รวบรวม E-Document ยื่น Fax Claim / E-Claim ผ่าน Portal พร้อมแนบ Checklist	30 นาที	Insurance Portal / HIS	First-Time Pass Rate ≥ 90%
5	ทีมประกัน / ระบบ	ติดตามผลการอนุมัติ หากมี Red Flag แจ้งเตือน ผู้ดูแล และบันทึกยอดอนุมัติลง HIS	50 นาที	HIS Billing / Portal	Query Rate ≤ 5%
6	การเงิน & พยาบาล	สรุปยอดส่วนต่าง รับชำระ ให้คำแนะนำหลังการ รักษา และปิดเคส Discharge ในระบบ	20 นาที	HIS Cashier & Pharmacy	Total SLA Compliance ≤ 150 นาที

5. ข้อเสนอแนะการกำกับดูแลและการรับมือเคสล่าช้า (Escalation Protocol)